

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082477-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VERA LUCIA FERREIRA BRIGGS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA CUMPRIMENTO NO PRAZO DE 30 DIAS. ENCAMINHAMENTO DA PARTE AUTORA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA. PEDIDO DE REFORMA PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA EM ATÉ 72 HORAS. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO PELA TURMA RECURSAL, EM DECISÃO QUE INTEGRA O JULGAMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão do evento 14 do processo originário de nº 5074829-52.2024.4.02.5101/RJ, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5082477-83.2024.4.02.5101

510014850843 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082477-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VERA LUCIA FERREIRA BRIGGS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual VERA LUCIA FERREIRA BRIGGS objetiva a reforma da decisão (**evento 14**) proferida âmbito do processo originário de nº 5074829-52.2024.4.02.5101, que deferiu o pedido de tutela provisória consistente no encaminhamento da parte Autora para realização de consulta em oncologia no prazo máximo de até 30 dias a partir de sua intimação para que a consulta seja realizada em até 72 horas.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (**evento 3**), a qual passa a integrar o presente voto:

*"Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora contra decisão do **evento 14** do processo nº 5074829-52.2024.4.02.5101, que deferiu o pedido de tutela provisória consistente no encaminhamento da parte Autora para realização de*

consulta em oncologia no prazo máximo de até 30 dias a partir de sua intimação, conforme os seguintes termos:

“Trata-se de ação proposta por VERA LUCIA FERREIRA BRIGGS, em face da UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, postulando liminarmente, a condenação das Rés a providenciarem CONSULTA EM ONCOLOGIA. No mérito, requer a confirmação da tutela.

Como causa de pedir, sustenta em síntese, que foi diagnosticada com neoplasia maligna do cólon ascendente.

Informa que foi encaminhada para avaliação oncológica e foi inserida no SER em 27/05/24, mas ainda não obteve atendimento.

Documentos que instruem a inicial – Evento 1 – Anexo 2.

Evento 10 – Parecer do Nat, acatado pelo Juízo, no sentido de que a consulta é indicada ao tratamento da parte autora. Esclarece que a parte autora foi inserida no SER em 27/05/24 e se encontra em fila. Informa que a via administrativa está sendo utilizada.

É o relato do necessário. Decido.

Defiro pedido de prioridade na tramitação do feito, em virtude de ser a parte autora pessoa idosa, nos termos preconizados pela Lei nº 10.741/03.

Também merece deferimento pedido de gratuidade de justiça, já que a parte autora obedece os requisitos traçados no art. 98 do Novo CPC. Caso a parte ré deseje impugnar o presente deferimento de gratuidade de justiça, deverá fazê-lo no prazo da contestação, sob pena de preclusão.

Entende-se que o pedido de tutela antecipada, como modalidade de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui-se em providência protetiva do bem jurídico tutelado pelo Direito, com a função de assegurar a entrega efetiva da prestação jurisdicional e possui como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, tenho que, no presente caso, encontram-se presentes ambos os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, conforme se verá a seguir.

A probabilidade do direito, apta a demonstrar a verossimilhança das alegações autorais, verifica-se a partir da análise detalhada dos documentos anexados à inicial, em harmonia com os fundamentos da parte autora, destacando-se os documentos que indicam a sua hipossuficiência econômica, de sorte que fica demonstrado não ser a parte requerente capaz de manter sua saúde às suas próprias expensas.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo evidencia-se a partir da gravidade da doença que acomete a parte autora e a necessidade premente do tratamento médico apontado na inicial.

Nos presentes autos, restou incontroverso através do parecer do NAT – Evento 10 que a consulta é indicada ao tratamento da parte autora. Esclarece que a parte autora foi inserida no SER em 27/05/24 e se encontra em fila. Informa que a via administrativa está sendo utilizada, senão vejamos:

Em síntese, trata-se de Autora com diagnóstico de **neoplasia maligna de cólon – adenocarcinoma tubular invasivo moderadamente diferenciado** (Evento 1, ANEXO2, Páginas 8 e 9), solicitando o fornecimento de **consulta médica em coloproctologia/oncologia** e o subsequente **tratamento oncológico** (Evento 1, INIC1, Página 7).

Assim, informa-se que a **consulta médica em coloproctologia/oncologia** e o **tratamento oncológico estão indicados** ao manejo terapêutico do quadro clínico da Autora – **neoplasia maligna de cólon** (Evento 1, ANEXO2, Páginas 8 e 9). Além disso, **estão cobertos pelo SUS**, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SUS (SIGTAP), na qual constam: **consulta médica em atenção especializada**, **tratamento clínico de paciente oncológico** e **tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades oncológicas**, sob os seguintes códigos de procedimento: 03.01.01.007-2, 03.04.10.002-1 e 03.03.13.006-7, considerando-se o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

Ressalta-se também que, somente após a avaliação do médico especialista (oncologista) é que será definida a melhor estratégia terapêutica para o quadro clínico da Autora.

No que tange ao acesso no SUS, a atenção oncológica foi reestruturada em consonância com a Rede de Atenção à Saúde e de forma articulada entre os três níveis de gestão.

O componente de Atenção Especializada é composto por ambulatorios de especialidades, **hospitais gerais e hospitais especializados habilitados** para a assistência oncológica. Esses devem apoiar e complementar os serviços da atenção básica na investigação diagnóstica, no tratamento do câncer (...), garantindo-se, dessa forma, **a integralidade do cuidado no âmbito da rede de atenção à saúde**. O componente da Atenção Especializada é constituído pela Atenção Ambulatorial e Hospitalar.

A Atenção Hospitalar é composta por hospitais habilitados como **UNACON** (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e **CACON** (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e por Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, nos quais são oferecidos os tratamentos especializados de alta complexidade, incluindo serviços de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e cuidados paliativos, em nível ambulatorial e de internação, a depender do serviço e da necessidade identificada em cada caso. Sempre com base nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, quando publicados.

Em consonância com o regulamento do SUS, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (**Deliberação CIB-RJ nº 4.004 de 30 de março de 2017**), o Estado do Rio de Janeiro conta com uma **Rede de Alta Complexidade Oncológica (ANEXO I)**¹.

¹ Deliberação CIB nº 4.004 de 30 de março de 2017. Pactuar “ad referendum” o credenciamento e habilitação das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, nas unidades abaixo listadas, em adequação à Portaria GM/MS nº 140 de 27/02/2014. Disponível em: < <http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib/540-2017/marco4593-deliberacao-cib-a-4-004-de-30-de-marco-de-2017.html>>. Acesso em: 25 set. 2024.



1



O ingresso dos usuários nas unidades que ofertam os serviços do SUS, ocorre por meio do sistema de regulação, conforme previsto na Política Nacional de Regulação que organiza o serviço em três dimensões (Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência) para qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde².

No intuito de verificar o correto encaminhamento da Autora aos sistemas de regulação, foi realizada consulta ao Sistema Estadual de Regulação (SER), onde foi identificada solicitação de consulta em **Ambulatório 1ª vez – Coloproctologia (Oncologia)**, inserida em 27/05/2024 pela Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia AP 33 para o tratamento de neoplasia maligna do cólon, com situação “**Em fila**”, ocupando atualmente a posição de nº 37ª na lista de espera (**ANEXO II**).

Assim, entende-se que a via administrativa já está sendo utilizada para o caso em tela, contudo sem resolução do mérito até a presente data.

Por fim, ressalta-se que “o paciente com **neoplasia maligna** tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), **no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único**”³.

É o parecer.

À 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

A necessidade e a urgência no tratamento pleiteado pela parte autora restaram corroboradas pelo laudo médico juntado no Evento 1 – anexo 2, o qual indica a urgência no início do tratamento da parte autora, senão vejamos:

SUPER CENTRO
CARIÓTIPO

Paciente: VERA LUCIA FERREIRA BRIGGS
Nascimento: 28/10/1963
Paciente: 150003278
Médico Requisitante: LETICIA M WERNECK

Data Exame: 21/09/2014
Laudado por: DR EDSON DE ALMEIDA
OS 25722-116

TC DO ABDOMEN SUPERIOR

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE

Técnica:
Aquisições volumétricas em aparelho multidetector sem a infusão de contraste endovenoso.

Relatório:
Fígado de morfologia, contornos e dimensões normais, densidade parenquimatosa habitual, apresenta hipodensos esparsos, aspecto pouco específico ao estudo sem contraste, mas no contexto sugerindo secundário.
Ausência de dilatações das vias biliares intra e extra-hepáticas.
Vesícula biliar com conteúdo heterogêneo.
Baço de morfologia, dimensões e densidade normais.
Pâncreas de dimensões e densidade normais.
Glândulas adrenais sem anormalidades.
Rins tópicos, com morfologia, contornos e dimensões normais.
Ausência de dilatação dos sistemas pielocalicinais.
Aorta e veia cava inferior de calibre e trajeto normais.
Espessamento do cólon ascendente, com linfonodomegalia em correlação, sugerindo no contexto.
Ausência de líquido livre na pelve em quantidade expressiva.
Linfonodo proeminente nas regiões inguinais.
Bexiga distendida, com conteúdo homogêneo.
Ampola retal centrada.

Este é um exame complementar e, como tal, deverá ser analisado por seu médico assistente para a decisão terapêutica.
"OBS: A impressão diagnóstica em exame de imagem não é absoluta, devendo ser correlacionada com exames laboratoriais além de outros exames de imagem prévios."

Laudado por:
DR EDSON DE ALMEIDA
52883832

Este laudo foi assinado eletronicamente

Soma-se a tais elementos o fato de que a tutela da saúde, estampada especificamente a partir do art. 196 da CF/88, deve ser perseguida não apenas pelo indivíduo, mas também pelo Estado (lato sensu), como corolário da dignidade da pessoa humana, fundamento de nossa ordem constitucional, prevista especificamente no art. 3º, III da CF/88.

Assim, não pode o Poder Público se furtar a tal dever, e, em que pese já existir previsão constitucional de um sistema próprio para o exercício de tal dever (art. 198 e seguintes da CF/88), sistema esse que deve funcionar de maneira impessoal, tal previsão não exclui a eventual tutela em particular, a determinados indivíduos, que, apesar de buscarem no SUS o atendimento de que necessitam, não o encontram.

Aliás, é tendo em conta justamente o que prevê o art. 198, § 1º da CF/88, no sentido de que a formação do Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, que fica caracterizada a competência da Justiça Federal para o feito, considerando-se o disposto no art. 109, I da Carta Constitucional. No mesmo sentido, não há se olvidar que a competência administrativa material comum é repartida entre os mesmos entes no que tange à prestação de ações de saúde e de assistência pública (art. 23, II, CF/88). E, assim, também a jurisprudência vem se inclinando para a formação de um litisconsórcio passivo entre os três entes federativos acima mencionados (por todos, veja-se: REsp. 507205/PR).

Verificado estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, norma subsidiária que lastreia a aplicação da Lei nº 10.259/2001, depreende-se ser possível, no caso em tela, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.574 - RS (2016/0151511-5) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : UNIÃO RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR : LOURENÇO FLORIANI ORLANDINI E OUTRO (S) - RS072741 RECORRIDO : ORIETA RECK FOLGIARINI REPR. POR : MARIA DE LOURDES FOGLIARINI - CURADOR ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO PELA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela União com fundamento no artigo **105, III, a, da Constituição Federal**, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (fl.294): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBTENÇÃO DE LEITO EM UTI NA REDE PÚBLICA. CABIMENTO. 1. União, Estados e Municípios detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ação onde postulado o fornecimento público de medicamentos. 2. Solidária a responsabilidade dos entes da Federação quanto ao fornecimento de medicamentos, é direito da parte autora litigar contra qualquer deles, sendo, também, os três entes igualmente responsáveis pelo ônus financeiro advindo da aquisição do tratamento médico postulado. 3. Os estabelecimentos credenciados junto à Rede de Atenção Oncológica não detêm legitimidade para figurar no polo passivo das ações onde postulado a disponibilização de medicamentos ou obtenção de leitos na rede pública de saúde. Embargos de declaração rejeitados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: i) artigo **267, VI, do CPC/1973**, ao argumento de que não é possível a condenação em favor do nosocômio, visto que o mesmo é somente terceiro interessado, não sendo parte no feito; ii) artigo 2º da Lei **8.080/1990**, dada a inviabilidade do ressarcimento de custo pela internação em hospital privado; e iii) artigo 7º, inciso IV, da Lei **8.80/1990**, visto que: a) eventual ressarcimento pelo SUS de atendimento realizado na via privada deverá, obrigatoriamente, obedecer aos parâmetros do próprio Sistema, por força do disposto no art. **199 da Constituição Federal** e sob pena de violação ao princípio da igualdade; b) "no que toca ao custeio final da prestação, ora requerido pelo Hospital privado, deverão os custos ser repartidos pro rata, visto não haver uma pactuação prévia no âmbito do SUS" (fl. 335). Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 368 e 370. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, no que diz respeito ao artigo **267, VI, do CPC/1973**, (e a tese a ele vinculada), verifica-se que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF. No mais, reprimido o fundamento exposto no recurso especial do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de que, no que se refere à condenação do ente estatal a custear o tratamento em hospital privado em hipótese de inexistência de vaga na rede pública, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. ALEGATIVA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. RESPONSABILIDADE DO SUS. AUSÊNCIA, DIANTE DAS PECULIARES DO CASO. SÚMULA 7/STJ. 1. A via eleita não é adequada à análise da suposta afronta ao disposto no art. 153 da Constituição do Estado de Santa Catarina, em face da Súmula 280 do STF, aplicável por analogia: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 2. Este Superior Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que "não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado" (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/4/2012). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1443556/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015) ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE

MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em razão das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, no sentido de que não havia leito vago em UTI da rede pública, do elevado do custo do tratamento, e do crítico estado de saúde do enfermo, a segurança foi concedida para impor ao Estado o dever de custear as despesas médicas efetivamente comprovadas em hospital privado. 2. A verificação da alegada inadequação da via eleita e da ausência de prova de direito líquido e certo, enseja nova incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 553.858/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014) Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial da União. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de julho de 2017. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator

Ressalte-se, por oportuno, que não há se falar em periculum in mora inverso, tal como ventilado no art. 300, § 3º do CPC, na medida em que a medida ora requerida em antecipação dos efeitos da tutela mostra-se totalmente reversível, já que não há qualquer dúvida suscitada, até o presente momento, acerca da premente necessidade da parte autora acerca do tratamento e/ou acompanhamento médicos ora requeridos, e, como se não bastasse, na eventualidade de deles não mais vir a necessitar, ou mesmo de quaisquer dos réus demonstrarem que a parte autora não os requer com boa fé, poderá cessar, imediatamente, o seu fornecimento, sendo admissível que aqueles entes que efetivamente procederam ao fornecimento do que ora se requer busquem o seu ressarcimento, através das vias próprias.

Por outro lado, o prazo de 72 horas postulado pela parte autora é incompatível à garantia da infraestrutura do serviço público de saúde às condições para o agendamento da consulta postulada.

*Diante de todo o exposto, defiro a gratuidade de justiça requerida, na forma do art. 98 do CPC, **CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA**, na forma do art. 300 do CPC e conforme fundamentação acima, solidariamente, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS (Tema 793 do STF e Lei nº 8.080/90), em máximos 30 (trinta) dias a partir da intimação da presente, providenciem o **ENCAMINHAMENTO DA PARTE AUTORA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA**, em nosocômio público na especialidade em Oncologia. Na impossibilidade, o encaminhamento para clínica ou hospital privado, **conveniadas ao SUS**, com o pagamento dos serviços prestados de acordo com a Tabela prevista no Convênio entre o Hospital/Clinica Privados e o SUS.*

O descumprimento da presente decisão, no prazo acima fixado, ensejará a aplicação de multa única solidária, a ser convertida em favor do Fundo da Defensoria Pública da União, no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), não afastada a adoção das demais medidas coercitivas aplicáveis à espécie.

*Destaque-se que, conforme restou sufragado pelo STJ (por todos, veja-se: AgRg no REsp 908616 / RJ), não se trata de pedido genérico quando se pleiteia o fornecimento de medicações necessárias ou demais medidas necessárias para que se proceda ao tratamento contínuo de uma enfermidade, de modo tal que, caso o tratamento e/ou acompanhamento médicos de que a parte autora necessita para o tratamento da **doença descrita na inicial** seja alterada, poderá requerer a adequação do seu fornecimento, no bojo destes mesmos autos. Entretanto, caso venha a ser diagnosticada com nova doença, para a qual sejam necessários outros expedientes, deverá requerê-los em nova demanda, tendo em vista a nova causa de pedir que exsurgirá.*

Expeçam-se mandados de intimação da presente para os réus, fazendo-o acompanhar do laudo médico da parte autora.

Decisão assinada digitalmente (certificação digital), na forma do art. 1º do Provimento Conjunto nº 4 de 16 de dezembro de 2005.

Citem-se os réus.

P.R.I.”

Recorre a parte autora alegando, em síntese, que a gravidade de suas condições clínicas não permitem que se aguarde o prazo de cumprimento determinado na decisão, diante da necessidade premente da providência.

Decido.

A tutela de urgência é medida excepcional, uma vez que é realizada mediante cognição sumária, devendo o juiz aplicar tal medida com parcimônia, restringindo-a aos casos em que se constate, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que é dever do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação, conforme artigo 196 da CF.

No tocante à determinação judicial que deferiu a liminar, por ser tratar de medida extraordinária, imprescindível se afigura a demonstração de absoluta gravidade do caso concreto, sob pena de preterir os demais usuários do Sistema Único de Saúde que também se encontram aguardando, em lista de espera.

Assim, em casos envolvendo o direito à saúde, a jurisprudência se mostra cautelosa, para evitar que aqueles que ingressam no Poder Judiciário recebam tratamento privilegiado em relação aos demais usuários do sistema único de saúde, que também aguardam na fila para a realização dos exames, em situação também gravosa.

No caso, verifica-se que a decisão impugnada já apresenta em seus termos todos os dados e argumentos que reconhecem a necessidade e urgência do pedido formulado pela Recorrente.

Entendo ter sido a decisão suficientemente fundamentada, especialmente porque foram apresentadas inúmeras razões que em favor da urgência da medida.

Quanto aos aspecto objeto de irresignação da Recorrente, este órgão revisor compartilha do entendimento do juízo de origem ora mantido, no tocante ao prazo para cumprimento da tutela específica pelos entes públicos.

Até mesmo porque não sendo prazo recursal, mas de cumprimento, e dado tempo em que foi proferida a decisão, o prazo de cumprimento já se encontra em curso e bem avançado.

A Lei n.º 12.732/12 preceitua que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único” (art. 2.º).

No caso, o prazo legal foi há muito superado, razão por que, em juízo de cognição sumária, vislumbro excepcionalidade que justifica a intervenção do Poder Judiciário a fim de garantir à recorrente o direito à saúde. Sendo assim, entendo que a liminar deferida vem para auxiliar no caso concreto o atendimento da lei acima transcrita.

Contudo, considerando as informações coligidas aos autos pela parte autora e ainda, o teor do parecer do NAT, não entendo presentes os requisitos constantes do art. 300 do CPC para o deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido.

Por fim, ressalte-se que o controle do prazo deve ser acompanhado junto ao juízo de origem, autor da determinação judicial, e órgão a quem compete a eventual reforço da medida.

Do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e MANTENHO, por ora, a decisão de evento 14 do processo nº 5074829-52.2024.4.02.5101.

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos para julgamento final.”

Logo, conforme as razões supra aduzidas, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão do evento 14 do processo originário de nº 5074829-52.2024.4.02.5101/RJ, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.